

Fecha Última Actualización: 03-03-2022 20:32:35

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Daniel Esteban Moreno Dinamarca
Edad : 50a 4m 0d
Dirección : Tres Oriente 8075 Pob. Sn. Greg

Rut : 11.878.450-2
Fecha Nacto: 03/11/1971
Comuna : La Granja

N° Archivo : 2203830
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9999 9999

N° Epicrisis
298055

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 02/03/2022 09:15

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 03/03/2022 20:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Shock Septico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis

Nombre: Daniel Moreno Dinamarca
Edad: 50 años
RUT: 11.878.450-2
FI CASR: 01.03.2022
FI UCI: 03.03.2022

Antecedentes:

- Médicos: DHC x OH Child B-C de larga data, sin adherencia a tto médico
- Quirúrgicos: s/a
- Hábitos: OH (+++) suspendido hace 2 meses, Usuario PBC (++)
- Inmunización COVID-19: 1 dosis

Anamnesis:

Paciente con antecedentes descritos. Datos obtenidos de ficha médica, sin familiares presentes al momento del ingreso. Consulta en SAPU el 01.03 por cuadro de 1 semana de evolución de disnea progresiva, CEG, tos y sensación febril no cuantificada, por lo que consulta. Refiere ser contacto estrecho COVID-19 intradomiciliario durante 2da quincena de febrero. Signos vitales de ingreso a SAPU destaca PA 97/57, FC 124, FR 22-25rpm, Sat 90% Fio2 ambiental, por lo que se deriva a Urgencia CASR. En este centro hospitalario, se reinterroga, destacando incremento de perímetro abdominal y desorientación en T/E. HGT de ingreso en 49. Se decide hospitalización. Se realiza TC TAP con contraste que es informado con extensa neumonía multifocal predominio hemitorax derecho, hepatomegalia y esplenomegalia, con ascitis moderada y engrosamiento del marco colónico. Durante procedimiento, se describe paro respiratorio, por lo que inicia RCP 2 ciclos, requiriendo 1 amp de adrenalina y 1 amp bicarbonato, procediéndose a manejo avanzado de vía aérea, sin incidentes. Se traslada a Reanimador, en espera de cupo UPC, el cual se genera hoy en la madrugada de hoy. Se toman exs de laboratorio, de la cual destaca: PCR COVID-19 negativa, Líquido ascítico con 58 leucocitos, glucosa 96, proteínas 8.0, INR 1.56, ttpk 47, Hb 10.7, RB 19380, Plaquetas 121000, PCR 286, Lactato 90.7, BilT/D 10.34/7.78, GOT/GPT 223/36, FA/GGT 315/2027, Crea 2.62, BUN 16.5, Glucosa 39, Albumina 2.5, Na/K/Cl 124/3.8/87, LDH 563

Paciente ingresa a UCI en muy malas condiciones generales, con pésima perfusión periférica clínica, con livideces en las

Fecha Epicrisis : 03/03/2022 20:32

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 03-03-2022 20:32:35

Página 2 de 2

piernas y en abdomen y tronco, frío a distal. Además con ascitis a tensión. Con drogas vasoactivas extremadamente altas, con NAD a 0,9 ug/kg/min. Lactato mayor a 100 y con acidosis metabólica severa. Además con falla hepática, de coagulación, respiratoria, con PaFiO2 muy deteriorada.

Se volemiza con Albumina, se transfunde PFC, corticoides y se pasa infusión de bicarbonato. Se cambia esquema ATB. A pesar de lo anterior paciente no logra ninguna mejoría, manteniendo dosis muy altas de NAD con PAM en límite bajo.

Se decide agregar infusión de adrenalina, y dada importante ascitis a tensión con probable hipertensión abdominal se decide drenar moderada cantidad de líquido ascítico.

A pesar de todos los esfuerzos, el paciente evoluciona mal, por lo que se avisa a familiares sobre su situación.

Paciente fallece acompañado de familiares a las 20:20 hrs

Diagnóstico de Egreso

- Shock séptico - 1. Falla orgánica múltiple
- 2. Neumonía Adquirida en la Comunidad
- 3. DHC

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Andres Aquevedo Salazar
Médico Tratante (Staff)